

台灣美國商會製藥委員會拜會討論議題

(一) 「2026 癌症創新論壇—實踐健康台灣願景：以精準投資樹立癌症照護全球新標準」活動總覽及敬邀部長參與之「領航對談」環節說明(含與談貴賓、形式及討論方向)---(國健署彙整中)

(二) 「2026 圓桌論壇—公私協力打造健康台灣」討論議題回顧

台灣美國商會感謝衛生福利部長期以來建立良好的溝通協商機制。本(2026)年度商會白皮書，製藥委員會呼應政府強化供應韌性之政策主軸，全面檢視藥品生命週期管理對長期投資台灣之影響，並提出下列建議：

1. 資源挹注的合理及永續性，強化新藥編列機制與 CDF 永續性

- CDF 擴大至百億規模之時程、預算執行率、長期財源與永續運作機制，以及 CDF 與常規健保給付之銜接安排，以確保病人用藥不中斷。
- 新醫療科技資源投入充足性之評估指標或工具，以及相關檢驗檢查技術、醫療機構設備與認證等配套措施。

健保署回應：持續優化 CDF 制度，爭取公務預算並精準預估健保轉銜經費，保障民眾權益

- (1) **推動暫時性支付制度**：健保署自 2024 年起先於健保總額內設立暫時性支付專款 24.3 億，2025 年由行政院以公務預算挹注健保基金 50 億元，於總額外成立「癌症新藥暫時性支付專款」，2026 年再編列 50 億元，累計 2025 年剩餘經費，目前專款額度已達約 87 億元，刻正爭取於 2027 年達到百億規模。
- (2) **建立 CDF 轉銜制度**：健保署於 2025 年 2 月 25 日公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，依據作業原則規範，適用「癌症新藥暫時性支付專款」的廠商，必須在提交建議書時一併提交「暫時性支付藥品再評估計畫書」，本署將綜合評估藥品的療床療效與安全性、對健保財務影響及成本效益，讓專款藥品後續可以轉銜健保收載，健保署將依各該藥品之申報藥費、HTA 預估藥費及財務衝擊等，編列預算以銜接健保給付，確保民眾用藥不中斷。
- (3) **持續優化前瞻式新藥評估平台**：健保署並於 2025 年 8 月優化「前瞻式新藥及新給付範圍預算推估登錄平臺(HS 平台)」，並函知各公協會轉所屬會員協助登錄。系統新增欄位主要以因應未來產品落地之臨床環境需求及政策推動，包括法規影響、

搭配檢測及環境設備等，並將新醫療科技（含新藥及新技術）之財務影響納入評估，期能於藥品給付前預備符合整體環境配套作業。

- (4) **成立行政法人國家醫療科技評估中心**：並為強化醫療科技評估量能，推動成立「行政法人國家醫療科技評估中心」，相關法案已經立法院一讀及黨團協商通過，刻正待二、三讀審議，期能透過 HS、HTA 精準化預估藥費，積極爭取公務預算，以真實世界數據輔助議價及持續爭取暫時性支付專款作為健保總額藥費緩衝等方式，讓癌症新藥可以加速收載，同時兼顧健保財務穩定與民眾用藥權益。

2. 優化給付協議與風險分擔制度，檢視藥品給付協議(MEA)

- 限量額度、藥費上限及返還比例等設計在全球藥價(IRP)影響下，需檢視提升合理性，並強化淨價與返還資訊保密，以兼顧健保財務永續、病人可近性及新藥在台穩定布局。
- 政府預計修正 MEA 法規內容方向、業界溝通機制與具體時程。

健保署回應：優化藥品給付協議制度，與各界研商可行之修法方向

- (1) **透過藥品給付協議 (MEA) 加速創新藥品收載**：為加速病患取得新藥，解決臨床證據、成本效益與預算影響等不確定性，自 2018 年起推動藥品給付協議 (MEA, Managed Entry Agreement) 機制，綜合考量臨床治療效果、醫療迫切需求等，由健保與廠商共同分擔財務風險，以保障國內病患能夠取得創新藥物。MEA 機制因保有較高的「Listing price (掛牌價/定價)」，在美國 MFN 制度，反而具彈性。
- (2) **持續與外界溝通修法方向**：為使藥品給付協議(MEA/PVA)制度朝可預測性、公開、平等之原則，健保署自 2023 年起已多次邀集藥業公會及外商在臺商會交換意見，持續就制度及法規修正方向與業界溝通。惟各界對相關條文尚無共識（主要為還款比例），為利現行協商之給付協議書簽訂作業易達成共識，已於 2024 年 10 月 23 日彙整現行「藥品給付協議書範本」，函送相關公協會酌參。
- (3) **規劃於 2026 年下半年再召開溝通會議討論**：因修正方向仍需凝聚各界共識，健保署將於 2026 年下半年，針對藥品給付協議(MEA/PVA)部分之條文召開分項討論會議，擬具共識後研商相關修法事項。未來希望透過溝通修法達到可預期性與透明。

3. 健全上市後藥品週期管理與藥價調整，優化藥品支出目標制(DET)及藥價調整

- 檢視 DET 基期值調整方向及國際藥價參考機制，並納入各國支付制度差異之考量，確保國際比價方法學具合理性。
- 藥價調整與智慧財產權保護高度連動；針對部分創新藥物在台上市後，可能快速因「過專利」認定而面臨價格調整，長遠恐有延後新藥上市之疑慮，從供應韌性角度應如何滾動修正。
- 政府朝向縮小藥價差目標之具體政策方案及時程規劃，避免影響高價值及創新藥品之可近性。

健保署回應：配合總統府健康台灣推動委員會指示，研議未來改革方向

- (1) **DET 制度重新檢討**：DET 已實施 10 餘年，調整制度基期與頻率確有重新檢討之空間，健保署已規劃於 2026 年下半年針對 DET 調價機制進行檢討，屆時亦將邀集各界進行討論以凝聚共識；並同時將 DET 議題納入國家衛生研究院論壇，研析各國藥價管控與醫療支付制度，以及這些國家在醫療給付制度上(包含藥費及其他醫療服務)的整體規劃，研擬可行性藥價調整方案。
- (2) **藥價調整與專利期限之研析**：
- A. 健保署現行收載之具主成分專利藥品，於健保給付至專利權期間(包括延長期間)屆滿之平均時間約為 9.57 年，廠商若及早申請新藥納入健保，則該藥品在專利期屆滿前可有較長時間的價格保障。
- B. 為使國內藥品價格能與國際市場合理接軌，同時針對未具主成分專利之藥品價格予以保障，健保署已於 2025 年 4 月 26 日公告修正「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，重新分類藥價調整之各大類，並新增第四大類，第四大類之定義為健保收載 10 年內，且未曾經過第一大類(專利期內)、第二大類(逾專利期五年內)之藥品，以作為創新藥品但未具主成分專利之藥品的保障，該大類在前五年參考第一大類、後五年參考第二大類調整藥價。
- C. 因新法修正後刻正規劃執行中，並考量具主成分專利藥品在藥價調整上之衡平性，健保署將先依修正條文之內容執行業務，並持續滾動進行檢討，保持與外界溝通之順暢。
- (3) **與 DET 議題同步討論縮小藥價差**：「健保藥品支付價」與「醫療院所採購藥品價格」與之間的差異，即「藥價差」，健保署透過藥價調查後之藥價差，調整健保藥品支付價，使其逐步接近市場交易情形，爰「藥價差」與藥價調整(DET)具高度相關性，將併同 2026 年下半年 DET 調價機制溝通會議時一併討論。

(三) 綜合討論

現今國際參考價（IRP）已對全球藥品市場布局產生影響，並促使各界重新檢視及評估各市場之投資優先順序。台灣在此趨勢下，並因應近期相關政策，爰有下列問題向部長請益：

1. 從藥品供應韌性及生命週期管理觀點出發，請問衛福部如何於下列關鍵政策面向建立長期誘因制度，以促進外商永續投資？
 - 為強化醫藥供應韌性，從本土產能與穩健引入國際創新藥品兩大面向有哪些政策或措施，來保障雙軌互補，供應穩定。
 - 臨床試驗與研發誘因（如本土試驗、國際多中心試驗之誘引機制，特別是在試驗核准速度上如何具備競爭力）。
 - 藥品審查與加速核准機制（含審查效率及與國際接軌策略，特別是信賴 100 的進度及新適應症加速之可能性）。
 - 健保給付制度之設計，包括暫時性給付、給付加成及給付協議（MEA）運用的永續，及現有藥品核價獎勵機制的優化。
 - 藥品定價與調整機制（如 DET、IRP 等）於藥品智慧財產保護與生命週期管理中之考量。近期為強化藥品市場供應穩定，政府規劃暫不施行藥品目標制度（暫停藥價調查 3 年）之政策規劃進度為何。

健保署回應：建構兼具全球合作與供應韌性的健保藥品政策環境，持續推動各項藥品政策改革。

(1) 推動各項藥品政策改革，針對創新藥品給予優惠核價，提升民眾對新藥的可近性

A. 2025年健保藥品政策改革：「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」部分條文修正及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」條文修正已於2025年4月26日公告，包含：推動平行送審，加速新藥收載、支持新藥在地製造、支持國內製造學名藥或生物相似性藥品及早進入市場、國內製造藥品給予優惠藥價、藥價合理保障等。

B. 推動平行審查機制：

- I. 為加速收載未滿足醫療需求(Unmet Medical Need)之藥品，健保署參考澳洲及加拿大平行送審(Parallel Process)機制，於自2024年1月1日受理平行送審案件，符合平行送審條件之藥品，於向食品藥物管理署申請新藥查驗登記時，可向健保建議給付，預估最快於藥品取得許可證後6個月內或

送件10個月內健保給付生效。

- II. 自2024年1月1日至2026年5月，符合資格且正式送件之癌症新藥計有15件，其中6項已生效給付(其中有2項屬 TFDA 加速核准藥品)。新藥自取得藥證至健保收載中位數約9.5個月(最短約3.5個月)。

C. 成立癌症新藥暫時性支付專款(癌症新藥基金, CDF)：

- I. 行政院於2025年由公務預算挹注50億元於健保基金，並設置「癌症新藥暫時性支付專款」，將受限健保總額無法收載的藥品用專款暫時支付。
- II. 截至2026年6月，該筆預算新增加收載8項新藥、3項擴增給付，用於治療兒童癌症、非小細胞肺癌、乳癌、大腸直腸癌及多發性骨髓瘤等病人，增加受惠人數約3,500人。
- III. 接軌國際治療指引：在接軌美國 NCCN 國際治療指引 (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 的部分，健保署也已經盤點肺癌、乳癌、大腸癌、肝癌、胃癌及前列腺癌等各項癌症，逐步讓台灣的治療與國際同步。

D. 建立風險分擔的藥品給付協議機制：

- I. 為加速病患取得新藥，解決臨床證據、成本效益與預算影響等不確定性，自2018年起推動藥品給付協議(MEA, Managed Entry Agreement)機制，綜合考量臨床治療效果、醫療迫切需求等，由健保與廠商共同分擔財務風險，以保障國內病患能夠取得創新藥物。
- II. 藥品給付協議機制在美國 MFN 制度，反而具彈性，自2024年起持續與各界溝通，並於2025年10月彙整現行「藥品給付協議書範本」供相關公協會參考，2026年亦規劃持續與各界溝通，研擬可行的修法方向，達到可預期性與透明。

(2) 持續滾動檢討藥品調價機制，提升藥品供藥韌性：

- A. **DET 穩定調整：**為穩定藥品供應，保障合理藥價，本署在進行 DET 調整時，會考量缺藥問題、供應穩定性，並結合食藥署的必要藥品清單，進行通盤性評估，以確保民眾用藥無虞。
- B. **合理參考國際藥價 (IRP)，健保資源合理分配：**
 - I. 除原本第二大類第一年藥價調整參考十國藥價(十國最低價)外，2025年修正「藥品價格調整作業辦法」，將第二大類第四年、第三大類(每三年一次，十國最低價*1.1倍-1.3倍)與第四大類調價時，納入十國藥價做為參考，

使台灣藥價不偏離國際趨勢。

II. 透過參考十國藥價機制，避免逾專利期之研發廠藥品價格偏離國際藥價，節省之經費將再投入新藥預算，可容納更多創新藥品，讓健保資源做最有效運用，後續將視執行情形進行滾動式檢討，兼顧合理藥價調整與藥品供應韌性。

C. **保障必要藥品價格：**針對「同時符合主管機關公告之必要藥品、國內製造項目（抗微生物製劑不在此限）及同分組未逾三項目」不予調整價格，且針對「通過專利挑戰、使用國產原料藥及臨床試驗刊載期刊之國內製造藥品」給予調整後可再加價10%的保障，並於2026年4月1日優先適用。

D. **適時調整健保支付價格：**收載之健保藥品若因成本不敷或匯率變動，可依藥物給付項目及支付標準第34條及第35條提出重新核價。近年(2024年-2025年)提高藥品價格約350項。

E. **配合國家藥物韌性整備計畫，鼓勵國產藥品：**行政院挹注衛生福利部80.4億元，健保署將協同食藥署共同強化國內藥品韌性，鼓勵醫療院所使用國產原料藥製成之國產藥品與製劑、國產針具及血液試劑等。

(3) **配合總統府健康台灣推動委員會指示，研議未來改革方向：**總統裁示自今(2026)年起暫停藥價調查3年，以利政府在期間進行更完整制度盤整與政策規劃，盤點藥品供應鏈、強化國家藥物韌性，爰健保署經指示與後續討論後規劃如下：

A. **2026年 DET 照常調整：**2026年2月25日公告之健保藥價調整(Drug Expenditure Target, DET)，為2025年藥價調查後調整之項目，2026年4月1日仍公告生效。

B. **非 DET 項目依法調整：**依據全民健康保險法第46條規定，保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格；藥品逾專利期第1年起開始調降，於5年內依市場交易情形逐步調整至合理價格。

C. **DET 機制重新檢討：**DET 已實施10餘年，調整制度基期與頻率確有重新檢討之空間，健保署已規劃於2026年下半年針對 DET 調價機制進行檢討(研議同步考量藥價差問題)，屆時亦將邀集各界進行討論以凝聚共識，以維持供藥穩定與合理藥價。

2. 在藥品查驗登記、健保支付標準與藥價調整機制高度相互連動的情況下，衛福部如何確保跨機關完善法規調和？特別是對於全面免除製售證明(CPP)下法規修正，連動藥品核價對臨床試驗規模認定部分。

健保署回應：持續保持食藥署與健保署間良好溝通機制，共同完善藥品核價與調價機制。

- (1) 健保署持續與食藥署在提供藥品優惠核價、保障合理藥價及缺藥事件等維持供藥韌性之議題，保持密切聯繫與溝通，並在橫向合作機制上持續精進，必要時亦不定期召開相關溝通會議，確保民眾用藥權益。
- (2) 有關全面免除製售證明(CPP)法規修正，食藥署就配合修正並刪除「藥品查驗登記審查準則」「藥品查驗登記審查準則」38條之1、38條之2，因涉及國內執行之臨床試驗之相關規範，為本署「藥物給付項目及支付標準」第17條、第21條：「第一類新藥，在國內實施臨床試驗達一定規模者，以十國藥價中位數加算百分之十核價。」之國內臨床試驗規定之依據，本署將持續與食藥署保持溝通，並就後續辦理情形持續關注，配合該署研議之新規劃修正相關藥品子法規。

3. 我們肯定衛福部為強化藥品供應韌性所做的努力，並持續與業界溝通相關配套。未來是否可在既有對話基礎上，及早溝通並考量實務合理性，尤其針對責任分擔及違約處理等制度，透過可預期的政策安排，將管理機制有效轉化為穩定供應之誘因？

健保署回應：持續保持與各界良好溝通機制，定期辦理藥品政策對外溝通會議，研擬可行方案。

- (1) 健保署於2025年4月26日公告修正藥品相關法規前，已於外界相關利害關係人辦理各項交流或溝通會議逾20場次，並於2025年7月16日、11月19日召開「2025年度健保藥品政策改革系列說明會」，對外說明2025年公告之藥品兩部子法規修法重點，並再次蒐集各界多次就健保藥品相關政策向本署提出改革建議。
- (2) 經綜整各界意見包含藥品費用支出目標制(DET)、藥品給付協議(MEA)、鼓勵學名藥及生物相似性藥使用、藥價差、藥品差額負擔、定型化契約及其他相關議題。2026年將優先針對DET及藥價差議題；藥品給付協議(MEA)議題召開兩場次溝通討論會議，期能透過持續與各界溝通，擬具共識後配合實務合理性，完善修正法規或試辦計畫之事宜。

115 年 7 月 6 日美商會到訪名單：

#	姓名	職稱	協辦公司
1	葉素秋	美商製藥委員會 共同主席	輝瑞
2	孫啟德	美商製藥委員會 共同主席	艾伯維
3	古佳成	美商製藥委員會 共同主席	嬌生
4	邱俐穎	製藥委員會 委員	輝瑞
5	李幸容	製藥委員會 委員	艾伯維
6	王楷皓	製藥委員會 委員	嬌生
7	關家莉	製藥委員會 委員	吉立亞醫藥
8	李佩容	製藥委員會 委員	諾華
9	李佳純	製藥委員會 委員	阿斯特捷利康
10	廖芷嫻	製藥委員會 委員	默沙東
11	田開瑋	製藥委員會 委員	葛蘭素史克
12	柯思遠	商務組 商務官	美國在台協會
13	陶令瑜	商務組 商務經理	美國在台協會
14	魏凱	商會 執行長	台灣美國商會
15	陳慶維	政府及公共事務資深經理	台灣美國商會
16	龐霽心	政府及公共事務經理	台灣美國商會
17	趙郁柔	活動及行銷企劃主任	台灣美國商會